

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

Dr. med. Irmgard Kamilli  
Fachärztin für Innere Medizin – Rheumatologie  
Physikalische Therapie und Naturheilverfahren  
Osteologe ( DVO )

81547 München  
Grünwalderstr. 72  
Tel.: 0 89/62 11-20 51  
Fax. 0 89/6211-20 52

Dr. med. Irmgard Kamilli – Grünwalderstr. 72 – 81547 München

Frau  
Dr. med. Anke Röser  
Ltd. Ärztin Zentrum Fußorthopädie  
Im Hause

München, 22.03.2021/svl

n/ Patient

**Betreff: Deniffel, Thomas, \*06.04.1994**

Sehr geehrte Frau Dr. Röser,

besten Dank für die Vorstellung des o.g. Patienten, der sich erstmals am 02.03.2021 in meiner Rheumasprechstunde vorstellte.

**Diagnose:**

1. HLA-B27 positive Oligoarthritis, DD beginnende Psoriasis-Arthropathie
2. Osteopenie
3. Vitamin D Mangel

**Anamnese:**

Der Patient berichtet, dass er seit 03/2020 Arthralgien am Zeh D2 links, zunehmend habe mit Schwellung Zehengrundgelenk und Zehenmittelfinger. Leichte Besserung nach Steroidinjektion. Er trug einen Entlastungsschuh bis 10/2020. Es erfolgte eine Operation am 16.02.2021 mit der Diagnose Ruptur Platte MTP 2 mit sekundären Knochenödem zweites Grundglied links, rezidivierende Synovitis MTP 2 links.

**Knochendichte mittels DXA Halogic-Divcovery:**

T-score Sch -0,9; LWS T -1,1.

**Laborwerte:**

Unauffällige internistische Werte, bis auf ein positives HLA-B27. Campylobacter negativ. ANA, ENA, ds-DNS unauffällig. Die weiteren Laborwerte waren unauffällig, insbesondere CRP mit 0,1 mg/dl.  
Pathologisch war ein erniedrigtes Vitamin D mit 25,8 ng/ml.

**Beurteilung und Verlauf:**

Aufgrund der Anamnese des Patienten handelt es sich um eine rezidivierende Entzündung des zweiten Zehengrundgelenk, Erguss, Ödem und Ruptur der Plantarplatte, die am 16.02.2021 operiert wurde. Die durchgeführte Histologie ergab eine local synovialitis, würde zu einer

Psoriasis-Arthropathie passen. Im MRT vom 13.01.2021 wurde ebenfalls der Verdacht auf ein Psoriasis-Arthritis geäußert.

Im immunologischen Labor fiel ein positives HLA-B27 auf. Das weiteren immunologische Labor war unauffällig. Der Patient trägt nun ein Entlastungsschuh, so dass aktuell die Klinik nicht beurteilbar war.

Im Zusammenschau der Befunde könnte es sich um eine beginnende Oligoarthritis HBA-B27 positiv an MT2 handeln mit Ruptur der plantaren Platte. Da bei dem Patienten erstmals und einmalig nur der zweite Zeh betroffen ist und keine weiteren klinischen Symptome aufgetreten sind, wurde mit ihm besprochen, erstmals nur naturheilkundlich mit Basica und Teufelskralle zu arbeiten

Zusätzlich bei Vitamin D-Mangel Einnahme von Dekristol 20.000 IE/Woche.

Wie vereinbart wird sich der Patient im Juni 2021 erneut bei Ihnen vorstellen, im Anschluss auch in meiner rheumatologischen Sprechstunde. Mit dem Patienten wurde besprochen, falls weitere Arthritiden auftreten sollten, könnte jederzeit eine Basistherapie, z.B. MTX oder auch kurzfristig Prednisolon, begonnen werden.

Nachtrag vom 20.3.21 Patient berichtet über schuppige bläschenartige Veränderung an den Fingerkuppen, wäre vereinbar mit Psoriasis Pustulosa.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Irmgard Kamilli  
Fachärztin für Innere Medizin  
Rheumatologie  
Osteologie ( DVO )



Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn  
Thomas Deniffel  
Ellenberg 116  
87499 Wildpoldsried

#### PRIVATKLINIK

Schön Klinik  
München Harlaching  
Grünwalder Straße 72  
81547 München  
Tel 089 6211-3420  
Fax 089 6211-3422  
PrivatklinikMuenchenHarlaching@  
schoen-klinik.de  
www.schoen-klinik.de

Zentrum für Fuß- und  
Sprunggelenkchirurgie  
Chefarzt:  
Prof. Dr. med. Markus Walther  
Telefon: +49 89 6211-2041  
Telefax: +49 89 6211-2042  
FUSSinfoMuenchen@  
schoen-kliniken.de  
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

München,

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

#### Vorläufiger Entlassungsbericht

18. Februar 2021

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über oben genannten Patienten, der vom 16.02.2021 bis zum 18.02.2021 im Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie stationär behandelt wurde.

#### Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links  
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

#### Nebendiagnose:

keine bekannt

Allergien: ☒ keine bekannt

Wir weisen darauf hin, dass dieser Entlassungsbericht nur der Information des weiterbehandelnden Arztes dient und damit die Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung sowie die sachgerechte Abrechnung danach nicht ausreichend beurteilt werden kann.

#### Therapie:

Operation am 16.2.2021:

totale Synovektomie und PE Entnahme MTP II links; Verkürzungs-OT MT II; Naht plantare Platte von plantar MTP II links

#### Anamnese:

Es erfolgt die geplante stationäre Aufnahme zur oben genannten operativen Therapie. Der Patient hatte sich zuvor in unserer Sprechstunde vorgestellt. Herr Deniffel berichtet seit April 2020 ohne erinnertes Trauma oder Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen, welche mit einer Schwellung im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links einhergehen. Eine Einlagenversorgung sowie zweimalige Injektion erbrachte keine Beschwerdelinderung.

SEITE 01/04

Schön Klinik München Harlaching  
SE & Co KG  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRA-Nr. 6442  
USt-ID-Nr. DE 185469297  
Pers. haft. Gesellschafter  
Schön Klinik Geschäftsführungs SE  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor  
Dr. Mate Ivancic  
Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN DE85 7007 0010 0834 8799 01  
BIC DEUTDE33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus  
Medizinische Privatuniversität Salzburg  
Focus Klinikiste Top Nationales  
Krankenhaus  
Orthopädie  
FIFA Medical Centre of Excellence  
Medizinisches Zentrum des  
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

**Klinischer Befund bei Aufnahme:**

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

**Bildgebende Diagnostik:**

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:

Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelphalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Röntgen Vorfuß links in 2 Ebenen postoperativ 17.02.2021:

Z.n. Weil Osteotomie Metatarsale 2 mit regelrechter Lage des Osteosynthesematerials.

**Labor**

| Bezeichnung                                | Ref.-Bereich | Einheit               | 13.1.21<br>16:48 | 13.2.21<br>10:55               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Ergebnis engl.<br/>nCoV-RNA (Wuhan)</b> |              |                       |                  | *<br>nicht<br>nachgewie<br>sen |
| CRP                                        | bis 0.5      | mg/dl                 | 0.1              |                                |
| Natrium                                    | 136-145      | mmol/l                | 138              |                                |
| Kalium                                     | 3.7 - 5.5    | mmol/l                | 4.4              |                                |
| Harnstoff                                  | 16.6-48.5    | mg/dl                 | 17               |                                |
| Kreatinin                                  | 0.67-1.17    | mg/dl                 | 1.04             |                                |
| GPT                                        | bis 41       | U/l                   | 60↑              |                                |
| glomeruläre<br>Filtrationsrate             | 80-140       | ml/min/1,7            | * 86.3↓          |                                |
| Leukozyten                                 | 4.0-10.0     | x 10 <sup>3</sup>     | 8.8              |                                |
| Erythrozyten                               | 4.5-5.9      | x 10 <sup>6</sup> /μl | 5.2              |                                |
| Hämoglobin                                 | 14.0-17.5    | g/dl                  | 16.5             |                                |
| Hämatokrit                                 | 40.0-52.0    | %                     | 46.0             |                                |
| MCV                                        | 80.0-96.0    | fl                    | 88.3             |                                |
| MCH                                        | 28.0-33.0    | pg                    | 31.7             |                                |
| MCHC                                       | 33.0-36.0    | g/dl                  | 35.9             |                                |
| Thrombozyten                               | 139-335      | 10 <sup>3</sup> /μl   | 294              |                                |
| Quick                                      | 71-118       | %                     | 100              |                                |
| INR                                        |              |                       | * 1.01           |                                |
| PTT                                        | 22,7-32,5    | sec                   | * 26.0           |                                |

**Material**

Abstrich

**Klinischer Verlauf:**

Nach Besprechung der verschiedenen Behandlungsoptionen, sowie der Vor- und Nachteile eines konservativen vs. eines operativen Vorgehens wurde die Indikation zur Operation gestellt. Der Eingriff sowie der postoperative Verlauf gestalteten sich komplikationslos. Wir begannen eine Mobilisation des Patienten am ersten

SEITE 02/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas \* 06.04.1994, M  
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

postoperativen Tag im Verbandschuh mit schmerzadaptierter Belastung der operierten Extremität. Es erfolgte eine Anleitung des Patienten zur eigenständigen Durchführung einer mobilisierenden Krankengymnastik des oberen Sprunggelenkes in Dorsalextension und Plantarflexion.

Am 18.02.2021 konnten wir Thomas Deniffel in Ihre weitere fachärztliche Behandlung entlassen. Zum Entlassungszeitpunkt sahen wir reizlose Wundverhältnisse.

**Klinischer Befund bei Entlassung:**

Der Allgemeinzustand ist gut. Es bestehen reizlose Wundverhältnisse. Die Sensomotorik ist intakt. Die Beschwerdesymptomatik ist unter Analgesie gut kompensiert.

**Procedere:**

Wundversorgung

Kramer Verband 2 Wochen.

Wundkontrolle und Verbandswechsel: 1-2 x/ Woche.

Fadenzug: 2 Wochen postoperativ.

Hochlagerung: 2 Wochen, danach bei vermehrter Schwellung.

Der redressierende Vorfußverband (Kramer-Verband) schützt die Weichteile und hat eine große Bedeutung für den Therapieerfolg. Bei verrutschtem oder fehlerhaft angelegtem Verband besteht das Risiko erneuter Fehlstellungen und eines schlechten Operationsergebnisses. Die Großzehe sollte gerade stehen. Eine „Überkorrektur“ ist dabei ebenso zu vermeiden. Eine Videoanleitung zur Anlage eines Vorfußverbandes findet sich unter [www.kramerverband.my-medibook.de](http://www.kramerverband.my-medibook.de)

**Medikamente**

Nach individueller Risikoabschätzung kann bei fehlender Ruhigstellung des Sprunggelenks und Vollbelastung des Beins auf eine medikamentösen Thromboseprophylaxe verzichtet werden.

Analgetische Therapie: Nur nach Bedarf; bei NSAR wie Voltaren oder Ibuprofen mit Kontrolle der Nierenwerte im Verlauf.

Zur Unterstützung des Kollagenstoffwechsels ist die Einnahme von Vitamin C 500 mg p.o. 1-0-1 für 3 Monate möglich.

Zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels empfehlen wir die Einnahme von Vitamin D3 p.o. 1000 IE 1-0-1 für 3 Monate.

**Hilfsmittel**

Verbandschuh für 6 Wochen.

Unterarmgehstützen nur bei Bedarf unterstützend in den ersten Tagen postoperativ.

**plantarisierender Tapeverband MTP II 6 Wochen**

starre Einlage bis Ende 3. postop. Monat

**Belastung**

Vollbelastung im Verbandschuh.

**Physiotherapie und Rehabilitation**

Lymphdrainage: Fortführung bei Schwellung.

selbständig voller Bewegungsumfang im oberen Sprunggelenk, selbständig Fortführung KG Zehengrundgelenk I, II, III, IV, V in Dorsalext./Plantarflex.,

**keine KG MTP II für 6 Wochen**

nach 6 Wochen Gangschulung im Konfektionsschuh mit starrer Einlage, Rigidusfeder

**4 Monate postop. kein Zehenspitzenstand**

**Wiedervorstellung**

Ambulante Wiedervorstellung 6 Wochen postoperativ zur klinischen und radiologischen Kontrolle (Röntgen Fuß 3 Ebenen unter Belastung), alternativ weitere Betreuung beim niedergelassenen Kollegen.

Im Falle einer vermehrten Sekretion der Wunde, zunehmender Rötung oder unklarer Schmerzzunahme

SEITE 03/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas \* 06.04.1994, M  
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

empfehlen wir eine kurzfristige ärztliche Kontrolle.

Wir bitten um zeitnahe Terminvereinbarung unter Tel.: 089 / 6211 - 2244 oder Email: MHA-Sprechstunden-Termine@schoen-kliniken.de  
Onlineterminvereinbarung unter: <https://www.doctolib.de/institut/muenchen/schoen-klinik-muenchen-harlaching-fusschirurgie-sprungelenkchirurgie>

Medikation

Aufnahme

Entlassung

| Wirkstoffbezeichnung und -stärke | Darr.-form | Gabeschema (Dosierung) |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| Pantoprazol 40mg                 | p.o.       | 1-0-0-0 (Stück)        |

Bem: solange NSAR-Gabe

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ibuprofen 400mg | p.o. | 1-1-1-1 (Stück) |
|-----------------|------|-----------------|

Bem: im Verlauf reduzieren, beenden

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| Paracetamol 500mg | p.o. | 1-1-1-1 (Stück) |
|-------------------|------|-----------------|

Bem: im Verlauf reduzieren, beenden

|                                 |      |                 |
|---------------------------------|------|-----------------|
| Vitamin C (Ascorbinsäure) 500mg | p.o. | 1-1-1-1 (Stück) |
|---------------------------------|------|-----------------|

Bem: für den Monat

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Enoxaparin 40mg | s.c. | 0-0-0-1 (Stück) |
|-----------------|------|-----------------|

Bem: nur wenn eine Vollbelastung nicht umgesetzt werden kann

Verordnungen

| ausgestellt am | Formular                 | Inhalt                                                                          |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16.02.2021     | Arbeitsunfähigkeit EMGMT | Erstbescheinigung, voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 25.02.2021 |

|            |                   |                                 |
|------------|-------------------|---------------------------------|
| 16.02.2021 | Rezept-Muster 16  | Pantoprazol 40mg Tbl N4 1-0-0-0 |
|            | Entlassmanagement | Enoxaparin 40mg s.c. 0-0-0-1    |

Nachfolgende Versorgungseinrichtung

Mitgegebene Befunde

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben  
mit freundlichen kollegialen Grüßen



Prof. Dr. Markus Walther  
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser  
Leitende Ärztin

Dr. med. Quirin Hartmann  
Assistenzarzt

SEITE 04/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas, \* 06.04.1994, M  
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

Schön Klinik München Harlaching

Pat.: Deniffel, Thomas

Geb.Dat.: 06.04.1994, M

### Kumulativbefund

|                    |                 |         |            |                   |
|--------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| Auftragsnummer     | Referenzbereich | Einheit | 21500684   | 05702319          |
| Probenentnahmedat. |                 |         | 13.01.2021 | 13.02.2021        |
| Probenentnahmezeit |                 |         | 16:48      | 10:55             |
| Befundersteller    |                 |         | Hauslabor  | MEDAT-<br>MIBI-KC |

#### Coronadiagnostik

|                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Ergebnis engl.   |  |  |  | *                     |  |  |  |  |  |
| nCoV-RNA (Wuhan) |  |  |  | nicht<br>nachgewiesen |  |  |  |  |  |

#### Klinische Chemie

|                                |           |               |         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| CRP                            | bis 0,5   | mg/dl         | 0,1     |  |  |  |  |  |  |
| Natrium                        | 136-145   | mmol/l        | 138     |  |  |  |  |  |  |
| Kalium                         | 3,7 - 5,5 | mmol/l        | 4,4     |  |  |  |  |  |  |
| Harnstoff                      | 16,6-48,5 | mg/dl         | 17      |  |  |  |  |  |  |
| Kreatinin                      | 0,67-1,17 | mg/dl         | 1,04    |  |  |  |  |  |  |
| GPT                            | bis 41    | U/l           | 60↑     |  |  |  |  |  |  |
| glomeruläre<br>Filtrationsrate | 80-140    | ml/min/1,73m² | * 86,3↓ |  |  |  |  |  |  |

#### Kleines Blutbild

|              |           |                       |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Leukozyten   | 4,0-10,0  | x 10 <sup>3</sup>     | 8,8  |  |  |  |  |  |  |
| Erythrozyten | 4,5-5,9   | x 10 <sup>6</sup> /µl | 5,2  |  |  |  |  |  |  |
| Hämoglobin   | 14,0-17,5 | g/dl                  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |
| Hämatokrit   | 40,0-52,0 | %                     | 46,0 |  |  |  |  |  |  |
| MCV          | 80,0-96,0 | fL                    | 88,3 |  |  |  |  |  |  |
| MCH          | 28,0-33,0 | pg                    | 31,7 |  |  |  |  |  |  |
| MCHC         | 33,0-36,0 | g/dl                  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |
| Thrombozyten | 139-335   | 10 <sup>3</sup> /µl   | 294  |  |  |  |  |  |  |

#### Gerinnung

|       |           |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| Quick | 71-118    | %   | 100    |  |  |  |  |  |  |
| INR   |           |     | * 1,01 |  |  |  |  |  |  |
| PTT   | 22,7-32,5 | sec | * 26,0 |  |  |  |  |  |  |

#### Labor Becker und Kollegen

|          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| Material |  |  |  | Abstrich |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|

#### Bemerkungen

05702319 Ergebnis engl. 13.02.2021, 10:55

SARS-CoV-2 RNA (Coronavirus) was not detected.

21500684 glomeruläre Filtrationsrate 13.01.2021, 16:48

Die Berechnung der GFR mit der MDRD-Formel bezieht sich auf eine Körperoberfläche von 1,73 m² und ist vorgesehen für Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren.

21500684 INR 13.01.2021, 16:48

Interpretation der INR Werte:

INR Wert ist ein Vergleichswert unter Antikoagulationstherapie

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

Thomas Deniffel  
80244045

**Bemerkungen**

INR 1,0 Normalbereich  
INR 2,0-3,0 niedrig dosierte Antikoagulation  
INR 3,0-4,5 hoch dosierte Antikoagulation

ohne Gabe von Antikoagulationstherapie liegt die Aussagekraft beim Quick

21500684 PTT 13.01.2021, 16:48

Eine verlängerte PTT kann auch durch das Vorliegen von Lupus Antikoagulation  
(z.B. Autoimmunerkrankungen) bedingt sein.

Sollten keine anderen Ursachen (Faktorenmangel, Heparintherapie) für die verlängerte PTT bekannt  
sein, empfiehlt sich der Nachweis des Lupusantikoagulation.

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)



SCHÖN  
KLINIK  
München Harlaching  
Privatlinik

Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn  
Thomas Deniffel  
Ellenberg 116  
87499 Wildpoldsried

PRIVATKLINIK

Schön Klinik  
München Harlaching  
Grünwalder Straße 72  
81547 München  
Tel 089 6211-3420  
Fax 089 6211-3422  
PrivatklinikMuenchenHarlaching@  
schoen-klinik.de  
www.schoen-klinik.de

Zentrum für Fuß- und  
Sprunggelenkchirurgie  
Chefarzt:  
Prof. Dr. med. Markus Walther  
Telefon: +49 89 6211-2041  
Telefax: +49 89 6211-2042  
FUSSinfoMuenchen@  
schoen-kliniken.de  
Termin: +49 89 6211 2244

BESCHEINIGUNG

18.02.2021

Wir bescheinigen Herrn Thomas Deniffel, geb. 06.04.1994, dass sich dieser seit dem 16. - 18.02.2021 bei uns in  
stat. Behandlung befand.

Prof. Dr. Markus Walther  
Ärztlicher Direktor

Schön Klinik München Harlaching  
Taina Ransmayr  
Station 42  
Krankenstation Harlacher Str. 51  
81547 München  
Tel. +49 89 6211-3420  
Fax +49 89 6211-3422

Schön Klinik München Harlaching  
SE & Co KG  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRA-Nr. 6442  
USt-ID-Nr. DE 185469297  
Pers. haft. Gesellschafter  
Schön Klinik Geschäftsführungs SE  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor  
Dr. Mate Ivancic  
Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN DE85 7007 0010 0834 8799 01  
BIC DEUTDE33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus  
Medizinische Privatuniversität Salzburg  
Focus Klinikliste Top Nationales  
Krankenhaus  
Orthopädie  
FIFA Medical Centre of Excellence  
Medizinisches Zentrum des  
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn  
Dr. med. Paulus Eberle  
Allgemeinmedizin  
An der Wilhelmshöhe 28  
87463 Probstried-Dietmannsried

Schön Klinik  
München Harlaching  
Harlacher Straße 51  
81547 München  
Tel 089 6211-0  
Fax 089 6211-1111  
KlinikMuenchenHarlaching@  
schoen-klinik.de  
www.schoen-klinik.de  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Zentrum für Fuß- und  
Sprunggelenkchirurgie  
Chefarzt:  
Prof. Dr. med. Markus Walther  
Telefon: +49 89 6211-2041  
Telefax: +49 89 6211-2042  
FUSSinfo@schoen-kliniken.de  
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Eberle,

München,

17.01.2021

wir berichten über oben genannten Patienten, der sich am **13.01.2021** in unserer Sprechstunde für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie vorstellte.

#### Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links  
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

#### Therapieempfehlung:

Es erfolgte eine ausführliche Befunderläuterung. Zur Vermeidung einer sekundären Fehlstellung der Kleinzehe sowie sekundären Arthrose im 2. Grundgelenk besteht die Indikation zur operativen Rekonstruktion der plantaren Platte. Zusätzlich sollte eine PE-Entnahme der Synovia aus dem 2. Grundgelenk erfolgen um eine chronische entzündliche Grunderkrankung abschließend auszuschließen (bei klinisch möglichem Aspekt einer Psoriasisarthritis). Ich habe den Patienten ausführlich über die Erfolgschancen und Risiken sowie über Therapiealternativen informiert. Einleitung der OP Vorbereitung für den 16. Februar 2021.

#### Anamnese:

Erstvorstellung. Der Patient berichtet seit April 2020 ohne Trauma und ohne Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen welche mit einer Schwellung einhergehen im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links. Eine Einlagenversorgung erbringt keine Beschwerdelinderung. Eine 2-malige Injektion zeigte ebenfalls keine langfristige Wirkung. Unter und nach Belastung kommt es zu einer deutlichen Anschwellung mit deutlichen Schmerzen im 2. Strahl welche mit Ibuprofen gut zu reduzieren sind.

#### Klinischer Befund:

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

#### Bildgebende Diagnostik:

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:

Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

SEITE 01/02

Schön Klinik München Harlaching  
SE & Co KG  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRA-Nr. 6442  
USt-ID-Nr. DE 185469297  
Pers. haft. Gesellschafter  
Schön Klinik Geschäftsführungs SE  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor  
Dr. Mate Ivancic  
Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN DE15 7007 0010 0834 8799 00  
BIC DEUTEM33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus  
Medizinische Privatuniversität Salzburg  
Focus Klinikliste Top Nationales  
Krankenhaus  
Orthopädie  
FIFA Medical Centre of Excellence  
Medizinisches Zentrum des  
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelfalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben  
mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. Markus Walther  
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser  
Leitende Ärztin

**Nachrichtlich an:**

Thomas Deniffel, Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn  
Dr. med. Paulus Eberle  
Allgemeinmedizin  
An der Wilhelmshöhe 28  
87463 Probstried-Dietmannsried

Schön Klinik  
München Harlaching  
Harlacher Straße 51  
81547 München  
Tel 089 6211-0  
Fax 089 6211-1111  
KlinikMuenchenHarlaching@  
schoen-klinik.de  
www.schoen-klinik.de  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Zentrum für Fuß- und  
Sprunggelenkchirurgie  
Chefarzt:  
Prof. Dr. med. Markus Walther  
Telefon: +49 89 6211-2041  
Telefax: +49 89 6211-2042  
FUSSinfoMuenchen@  
schoen-kliniken.de  
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

München,

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

17.01.2021

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Eberle,

wir berichten über oben genannten Patienten, der sich am **13.01.2021** in unserer Sprechstunde für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie vorstellte.

#### Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links  
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

#### Therapieempfehlung:

Es erfolgte eine ausführliche Befunderläuterung. Zur Vermeidung einer sekundären Fehlstellung der Kleinzehe sowie sekundären Arthrose im 2. Grundgelenk besteht die Indikation zur operativen Rekonstruktion der plantaren Platte. Zusätzlich sollte eine PE-Entnahme der Synovia aus dem 2. Grundgelenk erfolgen um eine chronische entzündliche Grunderkrankung abschließend auszuschließen (bei klinisch möglichen Aspekt einer Psoriasisarthritis). Ich habe den Patienten ausführlich über die Erfolgschancen und Risiken sowie über Therapiealternativen informiert. Einleitung der OP Vorbereitung für den 16. Februar 2021.

#### Anamnese:

Erstvorstellung. Der Patient berichtet seit April 2020 ohne Trauma und ohne Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen welche mit einer Schwellung einhergehen im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links. Eine Einlagenversorgung erbringt keine Beschwerdelinderung. Eine 2-malige Injektion zeigte ebenfalls keine langfristige Wirkung. Unter und nach Belastung kommt es zu einer deutlichen Anschwellung mit deutlichen Schmerzen im 2. Strahl welche mit Ibuprofen gut zu reduzieren sind.

#### Klinischer Befund:

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

#### Bildgebende Diagnostik:

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:  
Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

SEITE 01/02

Schön Klinik München Harlaching  
SE & Co KG  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRA-Nr. 6442  
USt-ID-Nr. DE 185469297  
Pers. haft. Gesellschafter  
Schön Klinik Geschäftsführungs SE  
Sitz 83209 Prien am Chiemsee  
Reg.-Gericht Traunstein  
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor  
Dr. Mate Ivancic  
Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN DE15 7007 0010 0834 8799 00  
BIC DEUTDE33XXX

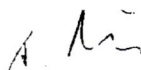
Lehrkrankenhaus der Paracelsus  
Medizinische Privatuniversität Salzburg  
Focus Klinikliste Top Nationales  
Krankenhaus  
Orthopädie  
FIFA Medical Centre of Excellence  
Medizinisches Zentrum des  
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (\* 06.04.1994 / # 8237)

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelphalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben  
mit freundlichen kollegialen Grüßen



Prof.Dr. Markus Walther  
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser  
Leitende Ärztin

**Nachrichtlich an:**

Thomas Deniffel, Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried